

Fecha Última Actualización: 04-02-2023 9:55:43

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Pedro Humberto Estrada Cuevas **Rut** : 17.612.386-9 **N° Archivo** : A622552
Edad : 32a 0m 30d **Fecha Nacto**: 05/01/1991 **Sexo** : Masculino
Dirección : Centro Penitenciario Huachalalume Sn **Comuna** : La Serena **Teléfono** : 2 27151 958

N° Epicrisis
339947

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto **Fecha Ingreso** : 04/01/2023 01:03 **Días Estadía**: 31
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad **Fecha Egreso** : 04/02/2023 09:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

herida penetrante torácica

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Paciente con antecedentes desconocidos, ingresa a reanimador por herida penetrante torácica por arma de fuego, HDN inestable, hipotenso, taquicárdico. Evaluación inicial con vía aérea permeable, ventilación espontánea, moviliza 4 extremidades, heridas en 2do espacio intescostal izquierdo 3er espacio intercostal derecho, 7mo-8vo espacio intercostal derecho, 7mo y 8vo LM escapular derecha. Eco fast --> positivo Se instala pleurostomía bilateral

Se realiza angioTAC de tórax: laceraciones pulmonares bilaterales, opacidades parenquimatosas con áreas de cavitación central en lóbulo superior derecho, lóbulo medio derecho y lóbulo superior izquierdo. Leve hemotórax derecho sin signos de sangrado activo + moderado neumotórax ipsilateral. Leve neumotórax izquierdo. Fractura por estallido del tercio proximal del cuerpo esternal.

Se realiza toracotomía anterolateral derecha el día 05/01, se evidencian lesiones superficiales en lóbulo inferior y lesión transixiante del lóbulo medio, se realiza tractotomía lóbulo medio, a demás Fractura expuesta de esternon, se aplica cera de hueso + control de daños de tórax con packing en región esternal + VAC. Se completa protocolo de transfusión masiva. Cirugía de control de daños sin incidentes-

Evoluciona grave, con DVA en dosis moderadas, VMI con fenta + midazolam en SAS 1 con FIO2 al 100%, destaca fuga en ventilador probablemente por fístula broncopleurale. Se reexplora en pabellón a las 48 hrs, donde retira packing, sin sangrado activo de pared ni parenquima pulmonar, se realiza rafia de pulmón derecho + cambio de VAC esternal, sin incidentes. Se realiza Fibrobroncoscopia con aspiración de abundante contenido hemático retenido.

Evoluciona en mejores condiciones, Realizandose 2 cambios de VAC hasta finalmente, cierre de pared con coljago muscual pectoral el día 16/01, se deja VAC prevena incisional. Evoluciona con alza de parametros inflamatorios, y peak febril, asociado a CAET con klebsiella erogenes, se mantiene tratamiento con tazonom con buena respuesta. Se logra estubación y destete de DVA, y paso a intermedio.

Durante estadía en intermedio presenta nuevo peak febril asociado a alza de parámetros inflamatorios, se inicia manejo atb empírico con imipenem. Es evaluado por infectología quienes deciden suspender a los 10 días. Sin embargo a las 24 hrs presnetan epak febril y alza de PI. Se solicita TC de tórax que muestra colección hipodensa pequeña en subcutaneo paraesternal, sin hemotorax solo DP leve.

SE reinicia ATB a la espera de pancultivos los cuales son negativos, con descenso de parámetros infecciosos por lo que se suspende ATB. Dede putno de vista nutricional, presenta tno deglutorio leve, en terapia con fonoaudiología hasta lograr ingesta

Fecha Epicrisis : 04/02/2023 09:55

Página 1 de 2

Fecha Última Actualización: 04-02-2023 9:55:43

Página 2 de 2

vía oral completa por boca hoy. Fonoaudiología autoriza regimen sin restricciones
Hoy hdn estable, afebril, en condiciones de continuar manejo en Hospital Penitenciario.

Diagnóstico de Egreso

TRAUMATISMO DEL TORAX, NO ESPECIFICADO - Trauma penetrante por arma de fuego

Condición de Egreso Alta Otro Destino

Egreso con Catéter Doble J:NO

Estable. Traslado a Hospital penitenciario

Plan Post Alta

- Reposo Realtivo
- Régimen blando
- Omeprazol 20 mg al día VO
- Paracetamol 1 gr c/ 8 hrs VO
- Ketoprofeno 50 mg c/8 hrs
- Quetiapina 100 mg c/ 12 hrs VO
- Aspirina 100 mg al día VO
- Kinesioterapia

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles



Bec. Francisco Lopez Delgado

Becado/Residente

INTERNO

Médico Tratante (Staff)